2026级新生心理普测面谈工作方案

一、工作目标

本次面谈工作依托“中国大学生心理健康筛查量表”（含22项筛查指标，详见附件：1）对2026级新生普测结果进行系统性二次评估。该量表通过三级筛查机制将学生划分为四类：“一类”为存在严重心理问题的学生，主要表现为幻觉等严重精神病性症状及自杀意向；“二类”为存在一般心理问题的学生，问题涵盖焦虑、抑郁等内化症状及敌对攻击、网络成瘾等外化症状；“三类”为存在发展性困扰的学生，涉及学校适应、人际关系、学业就业压力及恋爱困扰等方面；其余学生为“无风险者”。

面谈工作旨在对新生心理普测中评定为“一类”“二类”心理问题等级的学生开展系统性二次评估，通过专业化的半结构化面对面访谈，进一步评估其心理状态与风险程度，确保筛查结论的科学性与准确性。面谈将围绕学生当前心理状况、现实压力源及社会支持系统等方面进行，在此基础上精确界定风险等级，为后续差异化干预提供依据。通过本次面谈，切实推动心理危机预防关口前移，实现早期识别、科学评估与及时干预的有机衔接，有效防范校园心理安全危机事件发生，切实保障学生身心健康与生命安全，维护正常教学秩序和校园和谐稳定。

二、组织分工

由学生心理健康教育与咨询中心（以下简称心理中心）统筹协调，各学院、研究生培养单位（以下简称各单位）与校医院配

合落实，各单位职责分工如下：

心理中心：负责面谈统筹规划、组织面谈人员培训、面谈开展、风险评估、咨询干预及转介、面谈后全校重点关注库学生档案动态管理。

各单位：负责面谈开展、风险评估、面谈后日常关注、家校沟通、后续跟踪、本学院校级重点关注库学生档案动态管理。

校医院：负责提供医疗转介通道。

二、工作时间线及流程

（一）面谈前的工作

1.面谈培训

为保障面谈工作的顺利开展，心理中心将组织面谈专题培训。培训内容包括学生面谈的基本流程与沟通技巧、面谈记录表的规范填写要求、学生风险等级的判定标准及后续的干预要求。培训细节请见办公通知。

2.查看学生测试结果

在面谈前，面谈人须查看学生的测试结果，根据测试结果在面谈中有针对性地与学生进行沟通。

一类学生由专兼职咨询师负责面谈。关于学生测评报告的查看，由一校三地心理中心新生普测负责人内部统筹安排。

二类学生由学院辅导员负责面谈。心理辅导员须登录测试系统，查看本学院二类学生的测评报告，并下载发送至负责相应学生面谈工作的辅导员。

（二）面谈

一类学生：辅导员联系学生并安排至心理中心面谈，时间、地点由辅导员与对接学院的心理中心教师（以下简称学院对接教师）共同统筹安排。

二类学生：由辅导员联系学生，并安排至学院的二级心理辅导站进行面谈。辅导员若在与学生面谈中判断其心理问题较为复杂，应及时转介至学院对接教师，安排二次面谈。

所有面谈工作应在普测结束后3周内完成，每位学生面谈时间约为25分钟。面谈时间可根据面谈人与学生双方的时间安排灵活协调。面谈应依据面谈培训内容及“附件：3.2026级新生心理普测面谈要点及流程”所明确的要求与规范执行。

面谈过程中，若面谈人发现学生存在自杀、自伤、伤人等高危风险或行为，须立即启动心理危机干预程序，并第一时间向心理中心主任及学工、研工负责人报告。

在此特别说明：本次面谈工作涵盖一类及二类学生，但三类学生的心理健康状况同样不容忽视。辅导员应在日常谈心谈话中对其予以适当关注，力争做到早发现、早预防，确保心理关怀覆盖全体需要关注的学生。

（三）面谈后的工作

结束每位学生面谈后的3个工作日内，面谈人需完成填写《2026级新生心理普测初次面谈记录表》（附件：2）。

各学院在完成对全部一类及二类学生的面谈后，须组织召开

新生心理健康筛查面谈研判会。会议由学院分管学生工作副书记牵头，心理辅导员、新生辅导员及面谈人必须参加。本次面谈的核心任务，是要求面谈人将学生的具体状况向学院进行汇报。会议结束后，面谈记录表须统一归档管理。专兼职咨询师将面谈记录表交至中心新生普测工作负责人处，由其进行统一归档。学院辅导员则应将面谈记录表交至本学院心理辅导员处，负责本院材料的统一归档。

学院根据面谈人反馈的面谈情况，将符合以下三种风险等级的学生进行风险定级并进行后续的分类追踪干预。学生风险等级的划分与评定，严格以《山东大学重点关注学生预警与帮扶实施办法（试行）》中的“心理类重点关注学生分类表征”作为判定依据。分级标准如下：

1.红色预警

（1）风险等级的判定标准

状态极不稳定，当下存在高危风险，主要表现为以下情况。1.已经在医院明确诊断为精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、躁狂症等相关精神疾患，目前处于发作期，存在自伤/伤人/自杀的高危风险或行为；2.虽未明确诊断，但目前状态不稳定，出现意识不清、思维障碍（常见为思维奔逸、思维迟缓、幻觉、妄想）等症状，存在自伤/伤人/自杀等高危风险或行为。

（2）干预要求

立即报告：危机发现人第一时间报告心理中心主任及学工研

工负责人。

启动监护：安排专人24小时陪同看护，确保学生不脱离视线。

联系家属：通知学生家长（或法定监护人）尽快来校，面谈人与辅导员共同向家属说明情况。

转介评估：联系精神卫生机构进行专业评估，必要时启动强制住院程序。

全程记录：详细记录面谈信息、风险判定依据及已采取的干预措施，存档备查。

后期追踪：对于处于红色预警的学生，面谈人、学院对接教师、学院辅导员及学院领导应协同配合，持续关注学生动态，并切实落实部门间联动及家校沟通机制。待学生风险等级降低后，可依据下文规定的追踪频率与工作要求，对学生实施后续跟踪管理。

2.橙色预警

（1）风险等级判定标准

存在人格偏差，或处于精神类疾病康复期，表现为以下一种或多种情况叠加。1.确诊精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、躁狂症等精神类疾病，医生评估需要接受治疗（住院/服药）；2.表现为情感和行为的异常，但其意识状态、智力均无明显缺陷。人格偏离正常的社会文化要求，出现异常的行为模式，经常有情绪不稳、行为冲动、社会适应能力差等表现；对自身人格缺陷无

自知之明，难以从失败中吸取教训，重复出现类似的行为模式；3.曾出现过红色预警，经过干预处置，目前状态相对稳定，无自杀/自伤/伤人等高危风险或行为；4.本人半年内曾实施过自杀/自伤/伤人行为，经过研判，暂无高危风险；5.有生理缺陷或严重慢性疾病（包括长期严重失眠），长期为此感到强烈痛苦；6.情绪痛苦，社会功能严重受损。

（2）干预要求

对于橙色预警学生，辅导员应对学生进行定期追踪，追踪要求如下：

追踪主体、频率及动态风险评估：辅导员应对学生每周进行至少一次面谈或电话回访，持续不少于一个月；视情况稳定后可调整为每两周一次，逐步降低频率。在追踪过程中，辅导员应负责日常关心关注以及家校沟通，若出现情绪恶化、风险升级，应提高关注级别，重新评估风险等级。辅导员应鼓励学生寻求心理中心的专业帮助（如专业评估与咨询干预）。

档案管理：每次追踪均需记录学生当前状态、干预措施及下一步计划，形成完整追踪档案。

3.黄色预警

（1）风险等级判断标准

存在认知偏差、行为偏差、情绪困扰，可疑或确诊神经症，表现为以下一种或多种情况叠加。1.自我要求过高，或自我评价过低，自认为在各方面都很失败，导致持续的情绪低落、焦

虑、回避行为；性格孤僻，独来独往，不参与校园、班级活动，缺少社会支持等；2.日常行为异常（含沉迷网络游戏、参与网络借贷等），出现入睡性失眠、早醒性失眠、睡眠维持性失眠等睡眠障碍的情况；3.可疑或确诊神经症，包含焦虑症、强迫症、疑病症、恐怖症等，个体深感痛苦，社会功能受损，暂无自杀/自伤/伤人意向；4.曾出现过橙色预警，目前保持连续稳定状态半年以上，且近期无应激事件或明显压力；5.有自杀史，未再次实施过自杀/自伤/伤人的行为一年以上；6.因精神类疾病等原因休学的（须办理退宿手续），经过复学研判正常复学后，列为黄色预警学生；7.出现过自杀/自伤/伤人的想法，存在情绪困扰，社会功能轻度或中度受损。

（2）干预要求

对于黄色预警学生，辅导员应定期追踪，追踪要求如下：

追踪主体、频率及动态风险评估：辅导员应对学生每一个月进行一次面谈或电话回访。若在谈心谈话过程中发现学生的危机情况出现变化，应提高关注级别、重新评估风险等级。

档案管理：每次追踪均需记录学生当前状态、干预措施及下一步计划，形成完整追踪档案。

附件：1.22 项指标描述

附件：2.2026 级新生心理普测初次面谈记录表

附件：3.2026 级新生心理普测面谈要点及流程

附件：1

22项指标描述

一、一类心理问题

1.幻觉等严重精神病性症状：表现为出现幻听、幻视、被害妄想等精神分裂症常见症状。

2.自杀行为与意向：表现为有过结束自己生命的行为、准备或明确想法。

二、二类心理问题

（一）内化心理问题

3.焦虑：表现为烦躁不安、神经过敏、紧张及由此引发的躯体不适。

4.抑郁：表现为心境苦闷、兴趣减退、动力缺乏、失望悲观。

5.偏执：表现为过敏多疑、固执己见、极易记恨等不良个性特征。

6.自卑：表现为缺乏客观自我认识，不能悦纳自我，存在自我拒绝与否定。

7.敏感：表现为过分在意他人评价，容易因他人言行而受伤害。

8.社交恐惧：表现为害怕与人交往或当众说话，担心出丑而尽力回避。

9.躯体化：表现为心理障碍的躯体反映，如心血管、呼吸、

消化等系统的不适。

（二）外化心理问题

10.依赖：表现为过分顺从他人意志，严重缺乏独立性的个性特征。

11.敌对攻击：表现为在思想、情感及行为上的敌对表现，如厌烦、摔物、脾气爆发等。

12.冲动：表现为因微小刺激突然爆发强烈愤怒和冲动，且难以自控。

13.强迫：表现为反复出现不必要的想法、冲动或行为，明知不合理却难以控制。

14.网络成瘾：表现为因过度使用网络而导致明显社会、心理功能损害。

15.自伤行为：表现为在无自杀意图下，故意、重复地伤害自己身体的行为。

16.进食问题：表现为以进食行为异常为显著特征的综合征。

17.睡眠困扰：表现为睡眠过多、过少及其他与睡眠相关的症状。

三、三类心理问题

18.学校适应困难：表现为对大学校园生活方式、班集体生活适应不良。

19.人际关系困扰：表现为在人际交往中感到困难或不适。

20.学业压力：表现为在学习过程中承受较大压力。

21.就业压力：表现为面对未来就业问题时感到压力明显。

22.恋爱困扰：表现为在恋爱关系中遇到困难或阻碍。

附件：2

2026级新生心理普测初次面谈记录表

面谈日期：____年____月____日　面谈时长：_____分钟　面谈教师签名:____

<table>
<tr><td colspan="2">姓 名</td><td></td><td>性 别</td><td></td><td>学 院</td><td></td><td>学 号</td><td></td><td>A.本 B.硕 C.博</td></tr>
<tr><td colspan="2">生源地</td><td colspan="3">A.农村　B.城镇　C. 城市</td><td colspan="2">是否独生子女</td><td colspan="2">A.是　B.否</td></tr>
<tr><td colspan="2">籍 贯</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">以前是否住校</td><td colspan="2">A.是　B.否</td></tr>
<tr><td colspan="3">父母教育程度、职业</td><td colspan="3">父：</td><td colspan="4">母：</td></tr>
<tr><td colspan="2">婚姻状况</td><td colspan="3">A.未婚　B.已婚　C.其它</td><td colspan="2">是否参加过工作</td><td colspan="2">A.是　B.否</td></tr>
<tr><td colspan="2">普测时答题情况</td><td colspan="8">A.是真实作答　　B.未真实作答，原因是：</td></tr>
<tr><td rowspan="8">面谈后初步印象</td><td>问题程度</td><td colspan="8">A.一类：严重心理问题　B.二类：一般心理问题　C.三类：发展性困扰　D.无风险</td></tr>
<tr><td rowspan="7">问题类别（单选，在空格处打√）</td><td>同学关系</td><td></td><td>新生适应</td><td></td><td>睡眠问题</td><td></td></tr>
<tr><td>师生关系</td><td></td><td>学业问题</td><td></td><td>焦虑恐惧</td><td></td></tr>
<tr><td>家庭关系</td><td></td><td>生涯发展</td><td></td><td>抑郁悲伤</td><td></td></tr>
<tr><td>社会关系</td><td></td><td>自我探索</td><td></td><td>强迫现象</td><td></td></tr>
<tr><td>情感与性</td><td></td><td>生命意义</td><td></td><td>成瘾问题</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">其他问题（请具体说明）：</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>目前心理状况</td><td colspan="8">具体了解到的情况（请根据以下方面的情况具体阐述）：
（1）睡眠、饮食；（2）学业；（3）人际；（4）情绪；（5）情感；（6）重大生活事件；
（7）社会支持资源；（8）其它情况</td></tr>
</table>

附件：3

2026级新生心理普测面谈要点及流程

一、面谈要点

（一）一类学生面谈要点

一类学生指普测结果显示存在严重心理问题、可能处于急性心理危机状态者。其特征包括：存在中重度抑郁、焦虑、绝望感，可能出现自杀意念甚至具体计划，或存在精神病性症状，社会功能严重受损。此类学生是心理工作的最高优先级对象。

自杀/自伤风险：当前是否存在自杀意念、意念出现的频率与强度；有无具体计划（时间、方式、工具）及致命程度；既往是否有自杀未遂或自伤行为（此为最强预测因子）；近期是否有亲友自杀暴露史；有无告别行为、情绪突然“好转”等警示信号；是否已获取致命工具。

精神病性症状：是否存在幻听（尤其是命令性幻听）、幻视；是否存在被害妄想、被控制感、关系妄想；思维是否散漫、言语是否连贯；行为是否怪异或不合时宜；既往有无精神科诊断及用药史，近期是否停药。

重度抑郁与绝望感：情绪是否持续低落、有无晨重暮轻节律；兴趣是否全面丧失、是否终日卧床或呆坐；自我评价是否极低、有无强烈自罪感；对未来是否感到彻底无望（绝望感为自杀的重

要中间变量）。

急性应激与创伤事件：近期是否遭遇失恋、人际冲突、学业失败、家庭变故等重大事件；该事件是否超出其心理应对能力；当前是否处于急性应激障碍状态。

支持系统完整度：家庭结构是否完整（单亲、孤儿、留守等）；与家人关系是否支持或冲突；宿舍人际关系是否紧张；在校是否有信任的老师和朋友；遇到困难时是否有可求助的具体对象。

物质滥用与冲动控制：是否酗酒、药物滥用、过度依赖网络/游戏；是否有冲动性人格特质或暴力攻击行为史；近期有无冲动消费、危险驾驶等行为。

测评一致性判断：普测是否有效（有无掩饰性作答、答题时间过短等）；面谈表现与测评结果是否一致；是否存在“微笑型抑郁”（表面正常实则高危）或刻意掩盖。

（二）二类学生面谈要点

这类学生普测结果显示存在一般心理问题，虽不处于急性危机状态，但如缺乏有效关注与干预，微小心理问题可能积累放大。因此，对“一般心理问题”学生的关注，本质上是预防性工作——防止其向“严重心理危机”方向演化。

情绪状态：持续低落、兴趣减退；过度担忧学业或人际；情绪波动大、易激惹；注意表面开朗但私下困扰的隐性表现。

行为表现：出勤率下降、学业成绩骤降；社交退缩、回避集体活动；作息紊乱、网络过度依赖；个人卫生及生活习惯明显改

变。认知模式：频繁自我否定、无价值感；对前途悲观迷茫；注意力及记忆力明显减退。

生理状况：入睡困难、早醒、多梦；不明原因的躯体不适（头痛、胃痛、乏力）；精力持续减退。社会功能与支持系统：宿舍及同学关系紧张；单亲、留守、亲子关系紧张或经济困难等家庭因素；缺少可求助对象。

风险升级的触发因素：以下情形，可能使一般心理问题恶化：学业挂科、面临退学风险；失恋或重大情感挫折；家庭突发变故（亲人重病或离世、父母离异等）；经济状况急剧恶化；校园欺凌或人际孤立；环境突变（实习、转专业等）。

二、面谈流程

（一）面谈开场

面谈开场需完成两个任务：说明面谈目的，从利他角度切入，弱化学生防御心理；核实普测作答真实性，表达接纳态度，给予学生真实表达的空间。

话术示例：

“同学你好，我是心理中心的老师。普测后，有些地方想跟你进一步核实。今天想更详细了解你最近的状态。不用紧张哈，最近大家都参与了心理测评，我们会找一部分同学再聊一聊，看看大家最近的状况以及有没有需要帮助的地方。心理测评中的问卷是按照你的真实情况答的？还是因为忙，时间紧，没有仔细看题，随便答的？无论什么情况都没有关系，只要告诉我真实情况

就可以。谈话中，哪里有你觉得不舒服的地方可以不回答，我们慢慢来。”

（二）不同类别心理问题的询问

此核心评估环节是面谈的难点。自杀风险询问最忌突兀直问，应从一般情绪话题自然过渡，先聊近况建立信任，再逐步深入。以下话术供参考，实际面谈中应根据学生表述灵活调整。

1.从一般话题过渡到情绪状态

话术示例：

“最近开学这段时间，感觉怎么样？学业、生活还适应吗？……有没有什么让你觉得特别有压力的事？”

“最近压力大不大？有没有觉得焦虑或者情绪有些低落，想找人说说？”

2.从情绪状态过渡到自杀意念、精神病性因子的询问

（1）自杀意念

“你刚才提到最近觉得特别撑不住，这种感觉我理解。这种特别难受的时候，有没有出现过不想活了的念头？你跟我说说，没关系。”

从自伤行为过渡到自杀计划询问（如学生已承认有自杀意念）：

“谢谢你告诉我这些，能说出来本身就很不容易。我想再了解一下，这种念头出现的时候，你有没有想过具体怎么做？有没有想过什么时间？有没有准备过什么？”

（2）精神病因子

“最近有没有听到别人听不到的声音，或看到别人看不到的东西？”

“会不会总觉得周围有动静，但转头发现其实什么都没有？”

“会不会感觉不安全，觉得有人针对你或想害你？”

以上话术为示例模板，非固定脚本。面谈教师应根据学生的回应节奏灵活运用，核心原则是：先共情再提问，先轻后重，先意念后计划，逐步深入。